

恩主公醫院

健康檢查報告

姓 名：來賓 A

性 別：男

生 日：1966/01/01

身分證字號：A123456789

健 檢 編 號：0005432154

健 檢 套 裝：114 年鴻齡科技/新加坡鴻運科公司健檢套餐
-防癌 B-35000-(男)

健 檢 日 期：2025/02/05

報 告 醫 師：施子健 醫師

(2022Q2)恩主公醫院 BAD5310-201-01

目 錄

診斷及建議	3
主訴與病史	6
系統體格檢查表	7
理學檢查	8
眼科檢查	9
純音聽力會診	10
靜態心電圖	12
心律變異率檢查	13
身體組成分析	15
實驗室檢查	16
精密儀器檢查	19

十年心血管疾病風險	32
-----------------	----

診斷及建議 (Diagnosis and Suggestion)

器官顯著異常問題，立即門診診斷與治療無

個別器官異常問題，門診追蹤治療

1. 純音聽力會診檢查報告為右側輕度聽力損失：建議您避免長時間暴露高分貝聲響的環境，留意聽覺感受的變化，比對以往的測量結果，並至耳鼻喉科門診追蹤複檢，以了解聽力損失的種類及原因。如聽力損失程度影響到日常生活中語言溝通或聽覺品質時，可考慮使用助聽器。如有持續惡化的聽力減退、耳鳴、臉部麻痛、暈眩、平衡感失調等症狀，則應進一步檢查評估。
2. 腎絲球過濾率偏低：腎絲球過濾率隨著年齡下降，正常值約 90~125 ml/min/1.73m²，30-40 歲開始平均逐年下降 1 ml/min/1.73m²，如尿液持續出現蛋白尿或血尿，即可能為慢性腎臟病，建議您控制血壓、血糖、血脂肪，低鹽飲食，適度運動，避免亂服成藥或來路不明的草藥，並至家庭醫學科或腎臟科門診進一步檢查評估。
3. 主訴有糖尿病史，此次糖化血色素偏高：一般糖尿病患者的飯前血糖控制目標值為 80-130 mg/dl，糖化血色素控制目標值為小於 7%，飯後二小時血糖控制目標值為 80-160 mg/dl，建議您定時定量均衡飲食，避免攝取精緻醣類或高糖食物，選擇高纖及多樣化食物，每週進行至少 150 分鐘的中等強度耐力運動，甩油減重，定期檢測血糖，並回原就醫門診與主治醫師討論個別化治療計畫。
4. 甲狀腺超音波檢查報告為(1)右葉結節 0.81 公分(2)左葉囊腫 0.4 公分：建議您三個月內至新陳代謝科門診追蹤，如有持續增長、快速腫大、不對稱腫大或觸摸到腫瘤等，則應進一步評估治療。如您已經有在固定的門診追蹤，請遵循原主治醫師的建議。
5. 【1】腹部超音波檢查報告為輕度脂肪肝合併局限性無脂肪區【2】肝纖維化掃描為中度脂肪肝數值：有時肝臟中的脂肪分布不平均，在超音波檢查時，脂肪區域會呈現有如高回音結節的影像，需配合病史、血液檢驗及追蹤影像變化來判斷，建議您藉由飲食及運動控制消除脂肪肝，並至胃腸肝膽科門診追蹤複檢。
6. 腹部超音波檢查報告左腎鈣化點 0.5 公分：腎臟鈣化病灶的成因不明，多為良性變化，建議您調整飲食習慣，多喝水、多吃水果、少鹹、少肉、少喝茶與咖啡等飲料，預防尿路結石，並定期至腎臟科追蹤檢查。

7. 胸部 X 光檢查報告為主動脈粥狀硬化：動脈粥狀硬化會導致血管失去原有的彈性，管壁變厚變硬，管腔逐漸狹窄或形成血塊阻塞，引發心血管疾病，建議您積極防治三高慢性病，注意脂肪及膽固醇的攝取，保持標準體重及戒菸，延緩動脈硬化的進展。
8. 【1】胸部 X 光檢查報告為胸腰椎退化性病變【2】正子斷層造影發現第三、四腰椎右側交接處輕度葡萄糖吸收增加，為退化性變化：建議您避免提舉重物，減少腰部

負荷過重工作及久坐久站，多做脊椎伸展運動，保持脊椎活動範圍。如有慢性下背痛、無力、痠麻等症狀，則應至骨科或復健科門診進一步評估治療。

9. 正子斷層造影發現兩側上頸部小淋巴結輕微葡萄糖吸收增加，為非特異性淋巴腺炎：淋巴結為免疫器官，常見原因為一般感染造成反應性增生，少數為腫瘤等其他因素影響。若您有發現頸部可處觸摸到明顯增大腫瘤、其他不適，或是呼吸道久咳濃痰等症狀，請至家醫科進一步檢查。
10. 正子斷層造影檢查報告為正子斷層造影發現左下後牙床局部輕度葡萄糖吸收增加，應為牙科病症相關：若有不適症狀，可至牙科門診追蹤。
11. 正子斷層造影發現食道下端和胃竇部輕度葡萄糖吸收增加，應為輕度發炎反應：建議您調整飲食與生活型態，適量進食，避免咖啡、濃茶、碳酸及酒精性飲料，避免辛辣刺激、高熱量、高糖及高油脂食物，避免用餐後立刻躺下，睡前勿進食，睡覺時墊高頭頸部，戒菸減重多運動，少穿緊身衣褲。如有咽部灼燒感、火燒心、胃酸逆流、噯氣、打嗝等症狀，則應至胃腸肝膽科門診進一步評估治療。
12. 十年心血管疾病風險評估屬於中度風險：正常健康族群的冠狀動脈疾病發生率隨年齡增加而升高，一次預測屬性為低度風險，不代表未來十年內不會發生心血管疾病。同理，原預測屬於高度風險者，透過危險因子的控制與改善，能降低未來罹患心血管疾病的風險值。因此，建議您針對個別的危險因子，採取適當的健康管理措施，維持良好的飲食生活習慣，預防心血管疾病，並至家庭醫學科、代謝內分泌科或心臟血管科門診追蹤複檢。

器官輕微變化，如有相關症狀，請至門診複查

1. (1)體重過重(2)體質量指數肥胖(3)體脂率偏高且腹圍超標：肥胖與心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、高血壓、高膽固醇血症、睡眠呼吸中止症、癌症等疾病相關，建議您攝取均衡營養，維持規律活動，選擇中等強度全身有氧運動與肌肉耐力運動，搭配重量訓練增加肌肉量以提高基礎代謝率，補充足夠水分，減去多餘體脂肪，維持體態標準。
2. 有高血壓病史，此次血壓偏高：高血壓患者的家中血壓控制目標值為 130/80 mmHg，建議您採行健康的生活型態，低糖低鹽少油高纖飲食，不宜菸酒，規律運動，維持標準體重，調適壓力，睡眠充足，經常測量血壓，並回原就醫門診與主治醫師討論個別化治療計畫。
3. (1)眼底攝影檢查結果為雙眼視神經盤凹陷偏大：可能為生理性變異或與近視有關，也可能為青光眼或視神經疾病的表現(2)近視、散光：請加強視力保健，建議您定期至眼科門診追蹤。
4. 心律變異率檢查報告為心率變異性過大：心率變異性與同年齡相比，心率變異性數值過大，可能是正常有運動者或疑似心律不整亦或量測過程中訊號不穩定（可能過度深呼吸和量測環境不佳）所造成。
5. B 型肝炎表面抗原陰性、表面抗體陽性：代表您對 B 型肝炎有抵抗力，不用注射疫苗。
6. C 型肝炎抗體陰性：代表您沒有感染 C 型肝炎。
7. 尿潛血呈邊緣性反應：疑似偶發性、運動、藥物或尿路結石引起，建議您平時多喝水，定時排尿，勿憋尿，如有發燒、急尿頻尿、解尿疼痛、血尿等症狀，建議您至家庭醫學科或泌尿科門診進一步評估治療。
8. 阿茲海默症風險基因(ApoE)檢測結果為 $\epsilon 3/\epsilon 4$ ，與正常人相較的阿茲海默症風險倍數為 3 倍：請注意血脂變化並調整生活習慣及飲食。請詳見報告書分析及建議。

主訴與病史 (Chief Complaint and Medical History)

此次安排健康檢查原因

1. 原因：定期檢查

生活習慣

1. 過去一個月內是否有吸菸？：偶爾吸(不是天天)
2. 過去六個月內是否有嚼食檳榔？：從未嚼食
3. 過去一個月內是否有喝酒？：偶爾喝(不是天天)

用藥史, 藥物過敏史, 病史及手術病史

1. 慢性病：高血壓、糖尿病
2. 您是否曾動過外科手術？：(肩膀)、(耳膜)
3. 您是否對藥物過敏？：否
4. 您是否對食物過敏？：否
5. 您是否有在使用藥物？：抗血小板藥物(阿斯匹靈等相關)、高血壓、高血脂
6. 您目前是否有特殊治療情況？：無

家族史

1. 心血管疾病：父、外祖父母
2. 糖尿病：父

系統體格檢查表 (Physical Examination)

項目	結果	參考值
身高 (Body height)	163.2 公分	

體重 (Body weight)	74.9 公斤	49.8 至 67.4 公斤
理想體重範圍公式： 男性：[(身高-80)*0.7] ± 10 % 女性：[(身高-70)*0.6] ± 10 %		
體質量指數 (BMI)	28.1	國人標準：18.5-23.9
腹圍 (Abdominal girth)	91 公分	國人男性標準：小於 90 公分
脈搏 (Pulse rate)	67 次/分鐘	60-100 次/分鐘
血壓 (Blood pressure)	137/89 mmHg	120-90 / 80-60 mmHg
音叉	正常	

理學檢查 (Physical Examination)

項目	結果
頭 (Head)	無明顯異常
眼 (Eye)	無明顯異常
頸 (Neck)	無明顯異常
甲狀腺 (Thyroid)	無明顯異常
淋巴結 (Lymph node)	無明顯異常
胸 (Chest)	無明顯異常
心 (Heart)	無明顯異常
肺 (Lung)	無明顯異常

腹 (Abdomen)	無明顯異常
背 (Back)	無明顯異常
四肢 (Extremities)	無明顯異常
週邊血管 (Peripheral vessels)	無明顯異常
皮膚 (Skin)	無明顯異常
其他 (Others)	無明顯異常
建議 (Suggestion)	無明顯異常。

各科檢查(Inspection)

眼科檢查

	視力裸視	矯正視力	眼壓(<21)	電腦驗光	散光	辨色力
右眼	---	1.0	17	-5.25	-0.75	無異常
左眼	---	0.8	15	-4.00	-0.75	

免散瞳眼底攝影報告及影像



診斷 (Diagnosis) 視力(Visual

acuity): 近視、散光眼壓(Intraocular

pressure): 正常範圍

眼底(Fundus): 雙眼視神經盤凹陷偏大視網膜病變(Retinopathy):

無明顯異常黃斑(Macula): 無明顯異常

建議 (Suggestion)

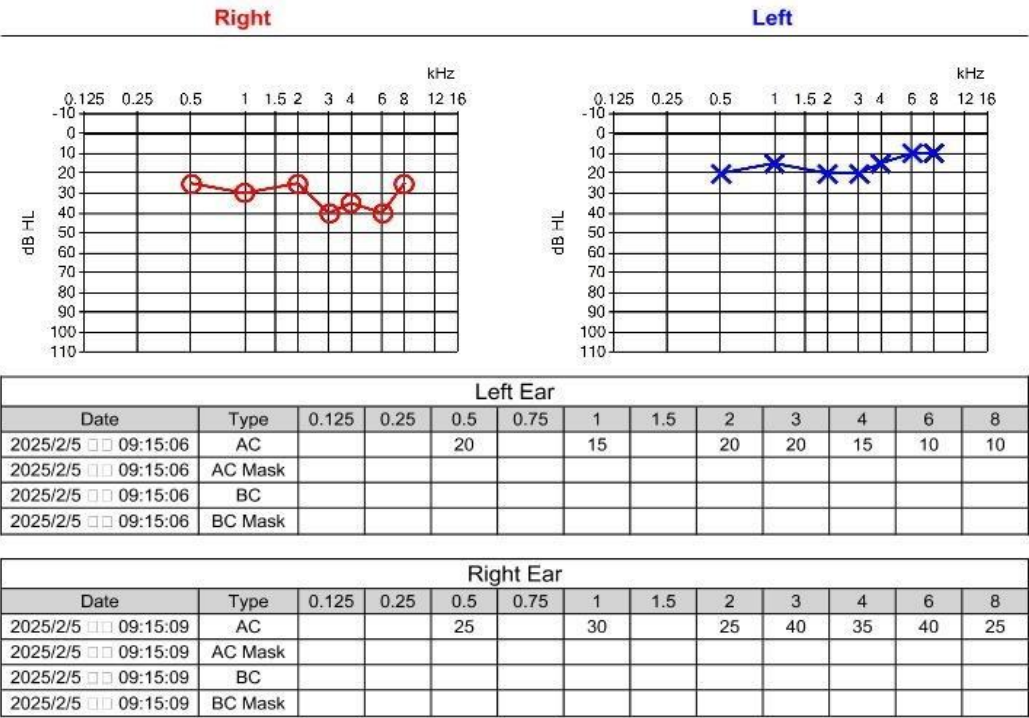
建議光學同調斷層檢查眼底攝影報告

雙眼視神經盤凹陷偏大

各科檢查(Inspection)

純音聽力會診

Patient ID: _____
Patient Name: _____
Date of Birth: _____
Gender: _____
Examiner/Signature: _____



全頻聽力

	500 赫茲	1000 赫茲	2000 赫茲	3000 赫茲	4000 赫茲	6000 赫茲	8000 赫茲
右耳	25	30	25	40	35	40	25
左耳	20	15	20	20	15	10	10

診斷 (Diagnosis)

耳(Ear): 右側輕度聽力損失

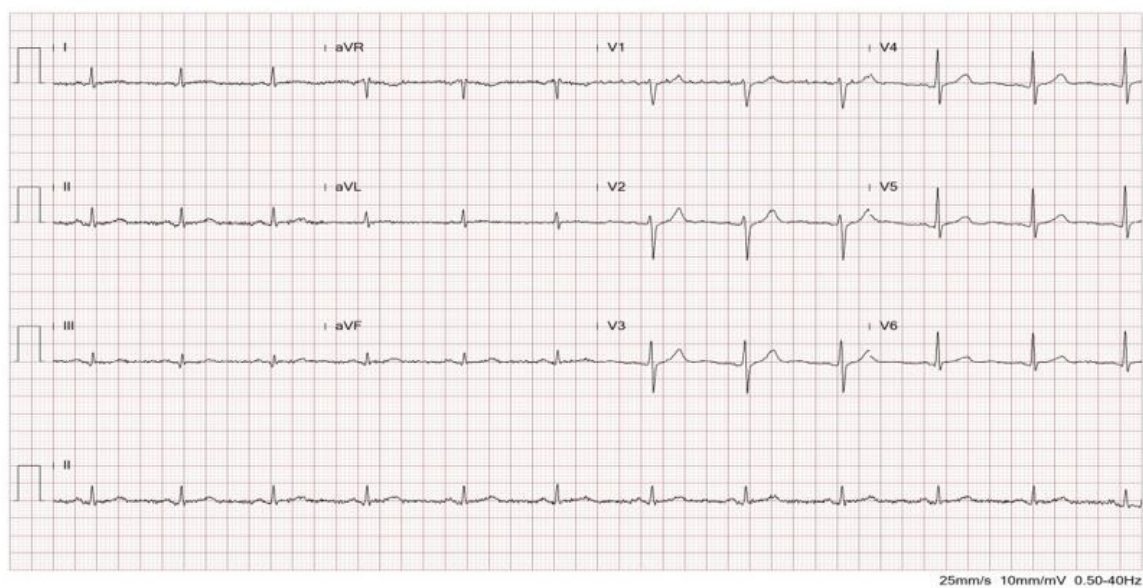
建議 (Suggestion)

若有相關症狀，請至耳鼻喉科門診就診。

各科檢查(Inspection)

靜態心電圖

Patient ID: 2025/02/05 08:55:11 9110 ** normal ECG **
Order Number: PEH142046001 1100 Sinus rhythm
Age: 58 Years Vent rate: 69 BPM Reviewed By: 施子健
Sex: M PR int: 156 ms Date: 2025/02/05 09:14:37
Name: QRS dur: 86 ms
Comment: QT/QTc: 380 / 399 ms
P-R-T axes: 52 35 57

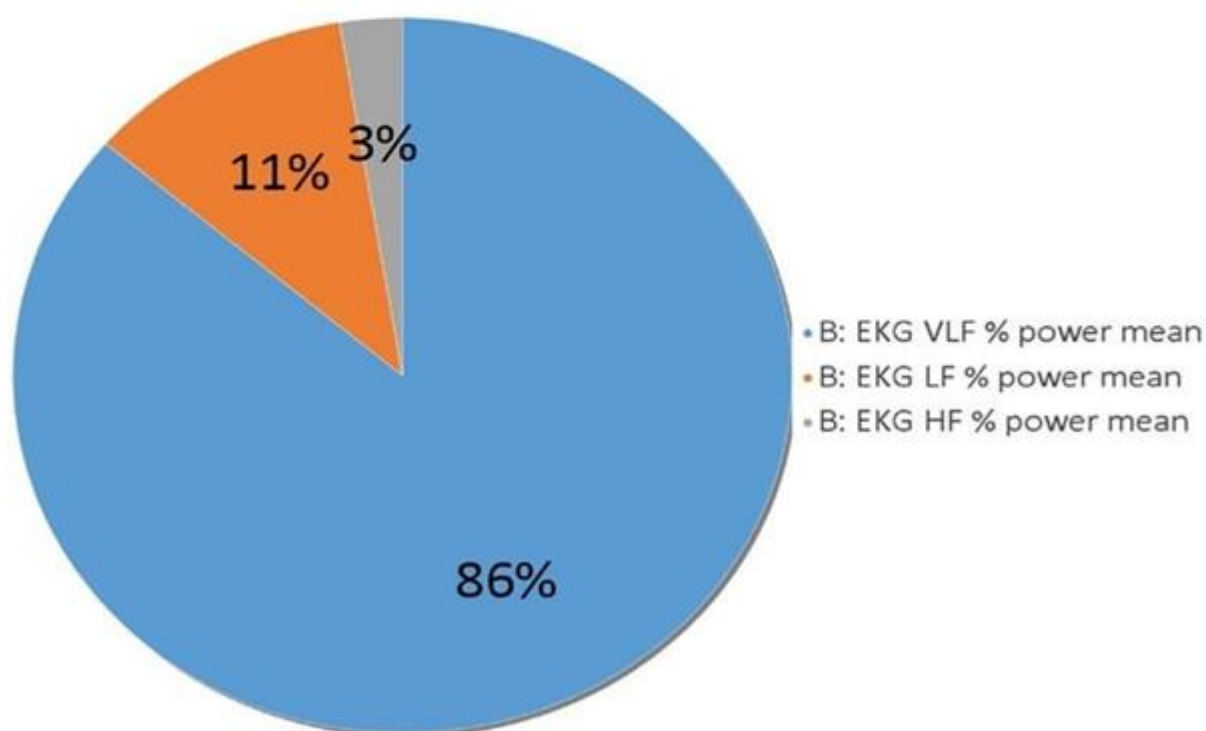


診斷 (Diagnosis) 無明顯異常

各科檢查(Inspection)

心律變異率檢查

自律神經檢測報告 HRV- Heart Rate Variability Report			
基本資料(請先核對基本資料，若有訛誤請告知檢查人員)			
姓名：	性別：	男	檢查日期：
出生日期：	身分證字號：		
檢測數據			
項目	檢測數值(單位)	標準範圍	
心跳速度(Heart Rate)	126.418	60~100(次/分鐘)	
自律神經偏向(Balance)	4.769		
自律神經總體功能(ANS)	0.939	> 50%	
交感神經功能(SYM)	7.229		
副交感神經功能(VAG)	0.217		
RSA呼吸心跳變異數	1.157	7-10次/min	
NN間距標準差(SDNN)	145.034	31.03(ms)	
自律神經分布圖			



心律變異率檢查

診斷 (Diagnosis) 心率變異性過大

建議 (Suggestion)

健康狀況: 心率變異性與同年齡的人相比, 心率變異性數值過大, 可能是正常有運動者或疑似心律不整亦或量測過程訊中訊號不穩定(可能過度深呼吸或量測環境不佳)所造成。

健康建議:

飲食方面: 多補充富含維生素 B 及 C 與鈣質, 能維持神經系統健康與穩定情緒。

運動方面: 可以從事重量訓練與跑步等較激烈的運動, 刺激交感神經活性, 促使心跳加速、呼吸變快與排汗量增加。

生活方面: 培養良好生活作息, 維持充足的睡眠。

健康監控: 定期監控 HRV 的數值, 了解身體目前的狀態, 若是 BMI > 24, 則需要注意體重的監控, 避免體重過重。

精密儀器檢查 (Precision instrument inspection)

身體組成分析



實驗室檢查 (Laboratory Examination)

檢查項目	本次	前次	本次參考值
血液檢查 (Blood Cell Exam)			
紅血球.(RBC(B))	5.01	---	4.5-5.9 $10^6/\mu\text{L}$
白血球(WBC(B))	6.4	---	3.9-10.6 $10^3/\mu\text{L}$
血色素(Hb)	16.4	---	13.5-17.5 g/dL
血球比容積 (Ht)	46.6	---	41-53 %
血小板(Platelet)	189	---	150-400 $10^3/\mu\text{L}$
平均紅血球色素量(MCH)	32.6	---	26-34 pg
平均紅血球色素濃度(MCHC)	35.1	---	31-37 g/dL
平均紅血球容積(MCV)	93.1	---	80-100 fL
嗜中性顆粒球(Neutrophil)	67.4	---	41-72 %
淋巴球(Lymphocyte)	22.5	---	19-47 %
單核球(Monocyte)	7.2	---	4-11 %
嗜伊紅顆粒球(Eosinophils)	2.4	---	0-8 %
嗜鹼性顆粒球(Basophils)	0.5	---	0-2 %
有核紅血球(NRBC)	0.0	---	0-0.4 /100WBC
生化檢查 (Biochemistry Exam)			
白蛋白(Albumin)	4.7	---	3.5-5.7 g/dL
總蛋白(Total protein)	7.7	---	6.4-8.9 g/dL

鹼性磷酸酶(Alkaline Phosphatase)	43	---	34-104 IU/L
肝功能檢查 (Liver Function)			
總膽紅素(Total Bilirubin)	1.16	---	0.26-1.22 mg/dL
直接膽紅素(Direct Bilirubin)	0.23	---	0-0.4 mg/dL
麩胺酸草醋酸轉氨基酶(AST)	23	---	0-40 IU/L
麩胺酸草丙酸轉氨基酶(ALT)	30	---	0-40 IU/L
丙型麩胺酸轉移酶(r-GT)	34	---	9-64 IU/L
腎功能檢查 (Renal Function)			
尿素氮(BUN)	17	---	7-25 mg/dL
肌酸酐(Creatinine)	1.19	---	0.7-1.3 mg/dL

檢查項目	本次	前次	本次參考值
腎絲球過濾率(eGFR)	66.74	---	90-125
血脂肪檢查 (Lipid)			
總膽固醇(Total Cholesterol)	147	---	<200 mg/dL
三酸甘油酯(Triglyceride TG)	132	---	<150 mg/dL
高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)	59	---	男>40; 女>50 mg/dL
低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)	75	---	<130 mg/dL
糖尿病檢查 (Plasma Glucose)			
飯前血糖(Glucose AC)	98	---	70-100 mg/dL
糖化血色素(HbA1c)	6.3	---	0-5.6 %
痛風檢查 (Gout)			
尿酸(Uric acid)	5.3	---	4.4-7.6 mg/dL
胰臟功能檢查 (Pancrease Function)			
胰臟澱粉酶(Amylase)	55	---	29-103 U/L
心臟血管功能檢查 (Cardiovascular Enzym Exam)			

高敏感度 C 反應蛋白(hs-CRP)	0.029	---	0-0.099 MG/DL
乳酸脫氫酶(LDH)	154	---	140-271 IU/L
肌酸磷化酶(CPK)	183	---	30-223 IU/L
甲狀腺檢查 (Thyroid Function)			
游離甲狀腺素免疫分析(Free T4)	0.74	---	0.59-1.43 NG/DL
甲狀腺刺激素免疫分析(TSH)	2.429	---	0.38-5.33 mIU/L
肝炎標記 (Hepatitis)			
B 型肝炎表面抗原(HBs-Ag)	Nonreactive(0.574)	---	Non-reactive(COI<0.9); Reactive(COI $\geq$ 0.9)
B 型肝炎表面抗體(Anti-HBs)	Reactive(211)	---	Non-reactive(<10 IU/L); Reactive($\geq$ 10 IU/L)
C 型肝炎抗體(Anti-HCV)	Nonreactive(0.0380)	---	Non-reactive(COI<0.9); Reactive(COI $\geq$ 0.9)
血液腫瘤標誌 (Tumor Markers)			
胎兒蛋白_肝癌指標 (Alpha-Fetoprotein)	2.8	---	<20 ng/mL
癌胚胎抗原(CEA)	3.7	---	不抽菸:<5.0; 抽 菸:<10.0 ng/mL
檢查項目	本次	前次	本次參考值
胰臟癌(CA-199)	<1	---	$\leq$ 35 U/mL
鼻咽癌指數(EBV-VCA IGA)	Negative(0.7)	---	<0.8, Negative
攝護腺特異性抗原(PSA)	1.430	---	<4 NG/ML
其它檢查 (Others)			
抗核抗體(ANA (IFA))	Negative<1:40	---	NEGATIVE
尿液檢查 (Urine Routine)			
尿液顏色(Urine Color)	Straw	---	Yellow
尿液濁度(Clarity)	-	---	NEGATIVE

尿液酸鹼度(pH)	6.5	---	5-8
尿蛋白(Protein)	< 15	---	<30 mg/dL
尿糖(Glucose)	< 50	---	0-49
尿酮體(Ketone)	-	---	NEGATIVE
尿比重(Specific gravity)	1.013	---	1.003-1.035
尿膽紅素(Bilirubin)	-	---	NEGATIVE
尿潛血(Occult Blood)	+/-	---	NEGATIVE
尿膽素原(Urobilinogen)	≤ 1.5	---	≤ 1.5 MG/DL
尿中亞硝酸鹽(Nitrite)	-	---	NEGATIVE
尿中白血球酯解酶(Leukocyte)	-	---	NEGATIVE
尿中細菌(Bacteria)	-	---	NOT FOUND /HPF
尿中柱狀細胞(Cast)	-	---	NOT FOUND /HPF
尿中結晶體(Crystal)	-	---	NOT FOUND /HPF
尿中上皮細胞(Epithelial Cell)	0-5	---	0-5 /HPF
尿中黴菌(Fungi)	-	---	NOT FOUND
尿中黏液(Mucus)	-	---	NOT FOUND /HPF
尿中紅血球(R.B.C.)	0-2	---	0-2 /HPF
尿中滴蟲(Trichomonas)	-	---	NOT FOUND
尿中白血球(W.B.C.)	0-5	---	0-5 /HPF
其他(Other)	0.0	---	無

精密儀器檢查 (Precision instrument inspection)

甲狀腺超音波檢查

報告
診斷 (Diagnosis) 右葉結節, 0.81 公分左葉囊腫, 0.4 公分 建議 (Suggestion) 三個月內追蹤

精密儀器檢查 (Precision instrument inspection)

腹部超音波

報告
診斷 (Diagnosis) 輕度脂肪肝合併局限性無脂肪區左腎鈣化點 0.5 公分

精密儀器檢查 (Precision instrument inspection)

肝纖維化掃描

報告

診斷 (Diagnosis) 肝硬度數

值: 正常脂肪肝數值: 中度

超音波影像



恩主公醫院

Shear wave 肝纖維化及脂肪肝掃描

病患姓名:	性別: M	檢查日期: 20250205
病歷號碼: (	病患來源:	檢查時間: 083553
年齡: 58	病床號碼:	編號: PEH16142046001

肝硬度數值 (Liver Stiffness) SWM (shear wave measurement) = 1.17

參考範圍:

纖維化等級	SWM Cut-off 值 (m/s)
正常 (F0)	≤ 1.19
輕度 (F1)	1.30
中度 (F2)	1.47
重度 (F3)	1.81
肝硬化 (F4)	≥ 2.00

註: SWM 為多次掃描後數值的平均值, 因為非侵入性檢查, 其診斷率會受部份因素影響(如脂肪肝、呼吸配合度、是否曾開刀、腸氣多寡...等), 判讀結果僅供臨床醫師參考, 最終仍需配合臨床醫師判斷是否需要其他輔助性檢查(如血液檢查、病理切片、影像檢查)。

脂肪肝數值 ATT (attenuation coefficient) = 0.67

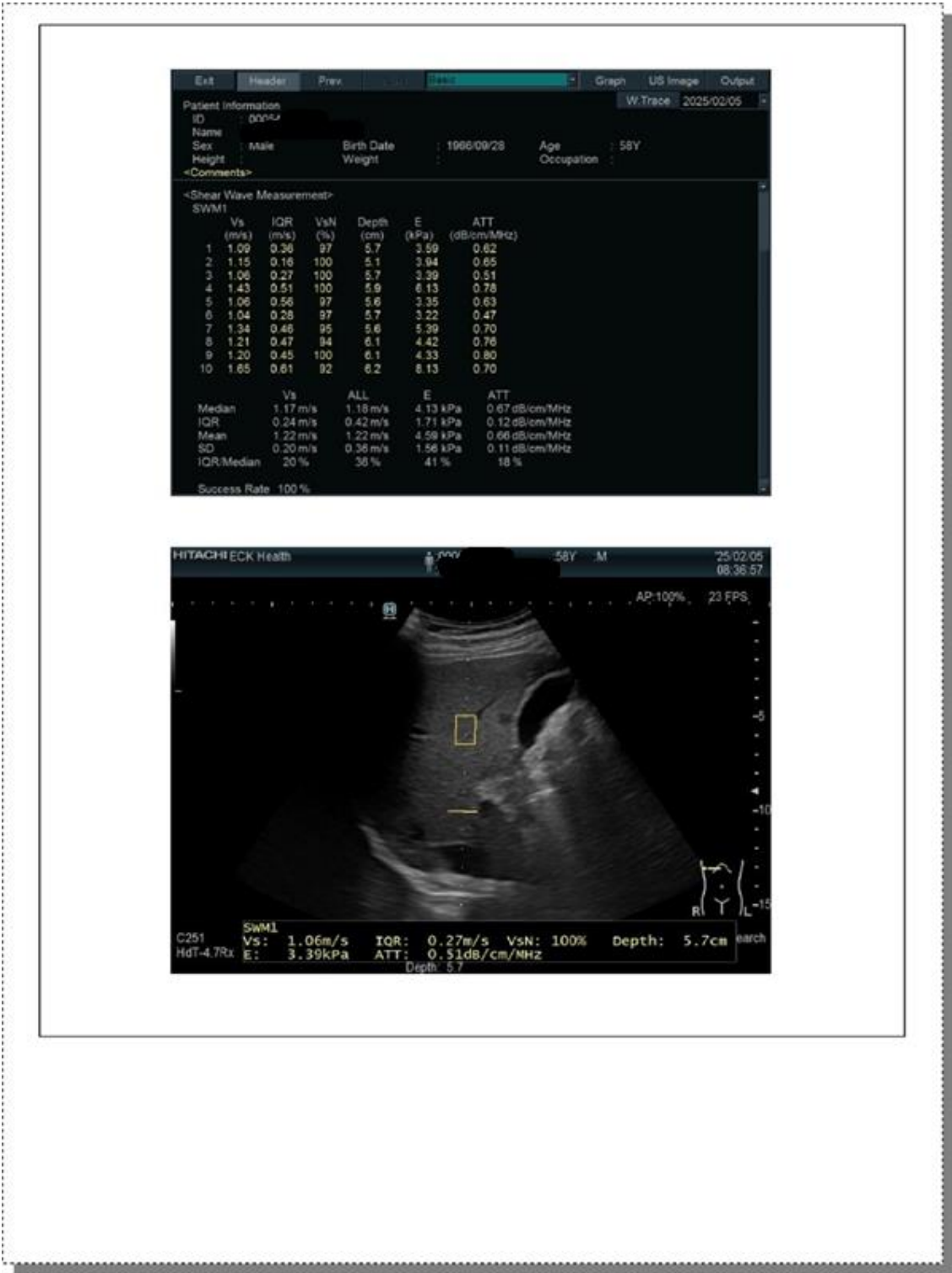
參考範圍:

脂肪肝等級	ATT 值 (dB/cm/MHZ)
正常 (S0)	≤ 0.61
輕度 (S1)	0.62-0.66
中度 (S2)	0.67-0.72
重度 (S3)	≥ 0.73

註: 若受檢者的皮下脂肪太厚, 有可能影響數值準確度。若 ATT 數值跟實際影像狀況有落差時, 應由醫師評估實際超音波狀況, 來判定脂肪肝程度。

Checker: 劉顯達醫師

超音波影像



精密儀器檢查 (Precision instrument inspection)

胸部 X 光檢查

報告

診斷 (Diagnosis)

無活動性肺病灶主動脈粥狀硬化

胸腰椎退化性病變

報告全部 (Total)

Chest (PA) showed:

- > No active lung lesion.
- > Normal heart size.
- > Atherosclerosis of the aorta.
- > Clear bilateral costophrenic angles.
- > Thoracolumbar spondylosis.

(Note: The false negative rate of exam of a chest X ray is up to 25%, not for diagnosis of lung cancer or metastinal tumor.)

注意：根據 ACR Appropriateness Criteria for Lung Cancer Screening, 單以胸部 X 光做為肺癌篩檢為不適當的。請勿以此檢查作為肺癌篩檢依據。請與您的醫師討論是否需要

接受進一步肺癌篩檢。(doi: 10.1016/j.jacr.2018.09.025)

精密儀器檢查 (Precision instrument inspection)

正子斷層造影

報告

診斷 (Diagnosis)

1. 正子斷層造影發現兩側上頸部小淋巴結輕微葡萄糖吸收增加，為非特異性淋巴腺炎。 2. 正子斷層造影發現左下後牙床局部輕度葡萄糖吸收增加，應為牙科病症相關。

若有不適症狀，可至牙科門診追蹤。

3. 正子斷層造影發現食道下端和胃竇部輕度葡萄糖吸收增加，應為輕度發炎反應。

4. 正子斷層造影發現第三、四腰椎右側交接處輕度葡萄糖吸收增加，為退化性變化。

報告全部 (Total)**【HISTORY】**

No history of malignancy. Referred for baseline study. Blood glucose: 97 mg/dL.

【PROCEDURE】

Following IV injection of 5 mCi FDG and a standard uptake period, the patient was imaged on mPET-CT scanner. Multiple bed position acquisitions were obtained from the upper thigh toward the head. The images were reconstructed with OSEM method and resliced into coronal, transaxial and sagittal projections.

【FINDINGS】

- Faint increased FDG uptake in bilateral upper neck small lymph nodes, probably due to non-specific lymphadenitis.
- Focal mild increased FDG uptake in the left lower posterior dental bed, indicating dentopathy.
- Mild increased FDG uptake in the distal esophagus and gastric antrum, probably due to mild inflammation.
- Focal mild increased FDG uptake in the right L3/4 vertebral junction due to degenerative change.

正子斷層造影

【IMPRESSION】

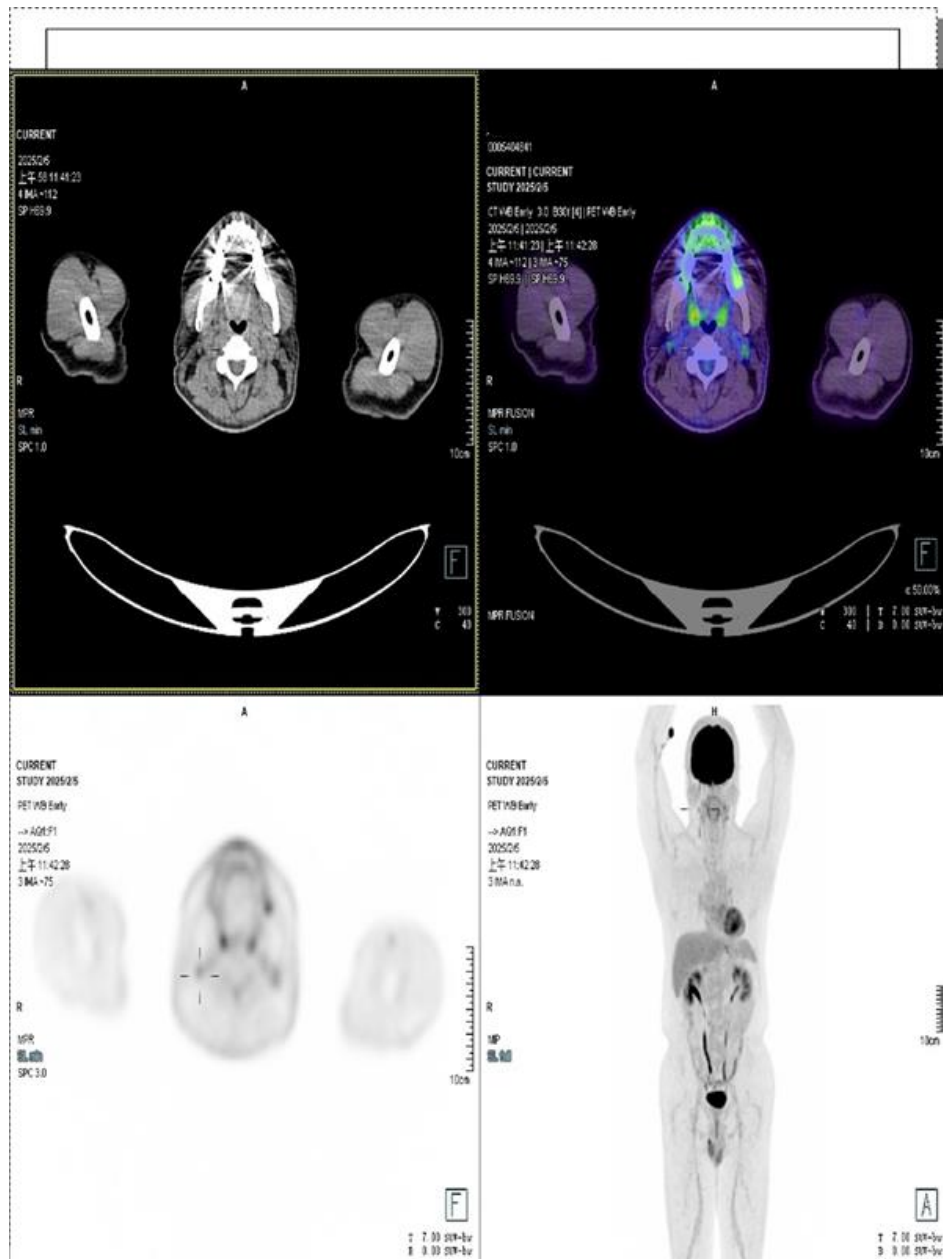
1. Non-specific bilateral upper neck lymphadenitis.
2. Probably left lower posterior dentopathy. Dental OPD follow up is recommended, if symptomatic.
3. Probably mild inflammation in distal esophagus (r/i reflux esophagitis) and gastric antrum.
4. Mild degenerative change in right L3/4 vertebral junction.

【附註】

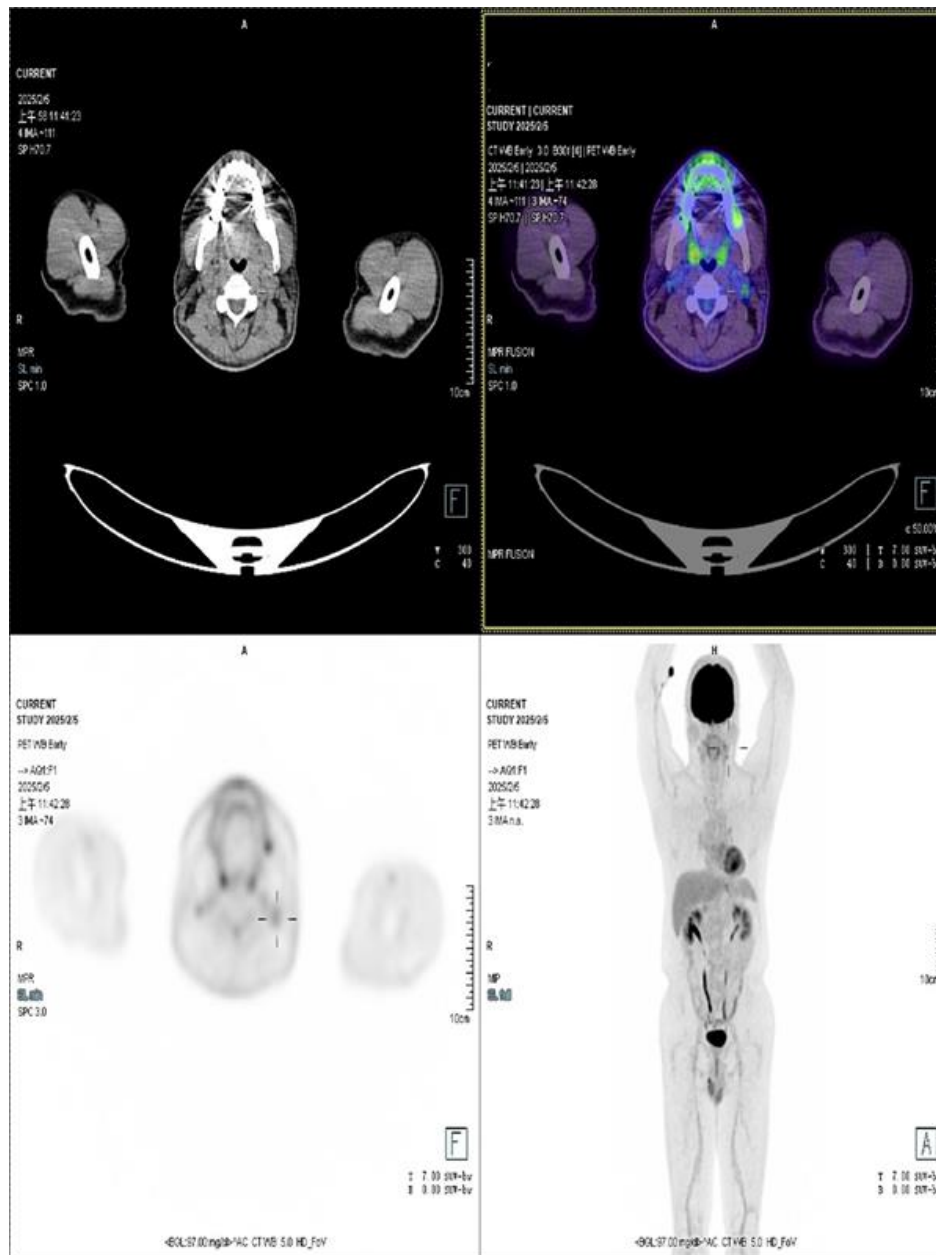
正子斷層造影是一種先進的醫學影像檢查，對癌症的早期篩檢和臨床分期判定、治療效果評估，具有極高之價值。然醫療科技發展至今，仍有其限制與不足之處，加上癌症細胞生長速度瞬息萬變、部分癌症細胞組織不攝取葡萄糖，故尚無任何一種醫療儀器足以確保百分之百偵測出微小癌細胞。因此，我們以最慎重的態度，在正子斷層造影健康檢查項目中，務求正確診斷出有無腫瘤的發生，必要時尚需轉診臨床專科醫師安排相關之理學檢查、內視鏡或抹片檢查。

正子斷層造影

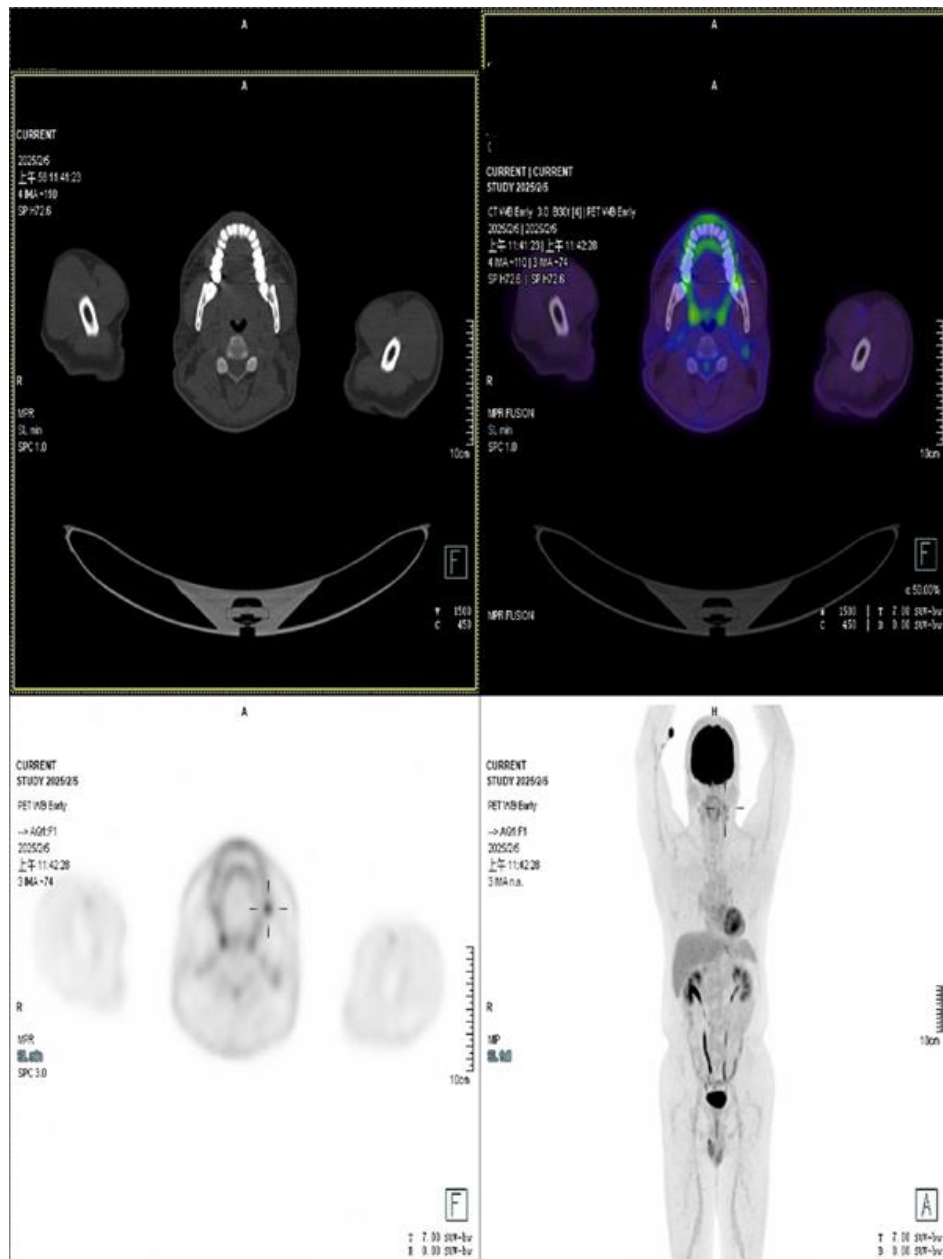
正子斷層造影



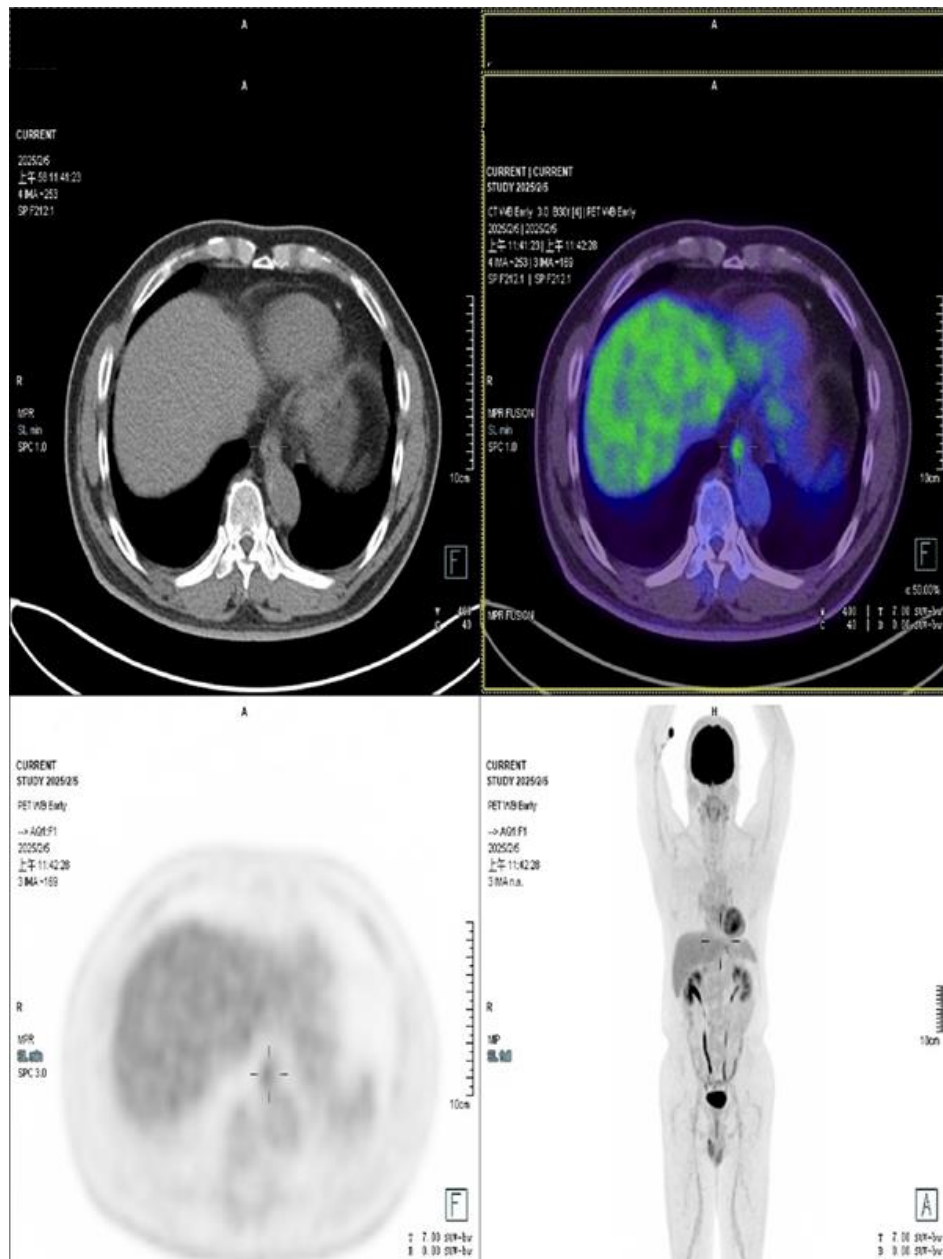
正子斷層造影



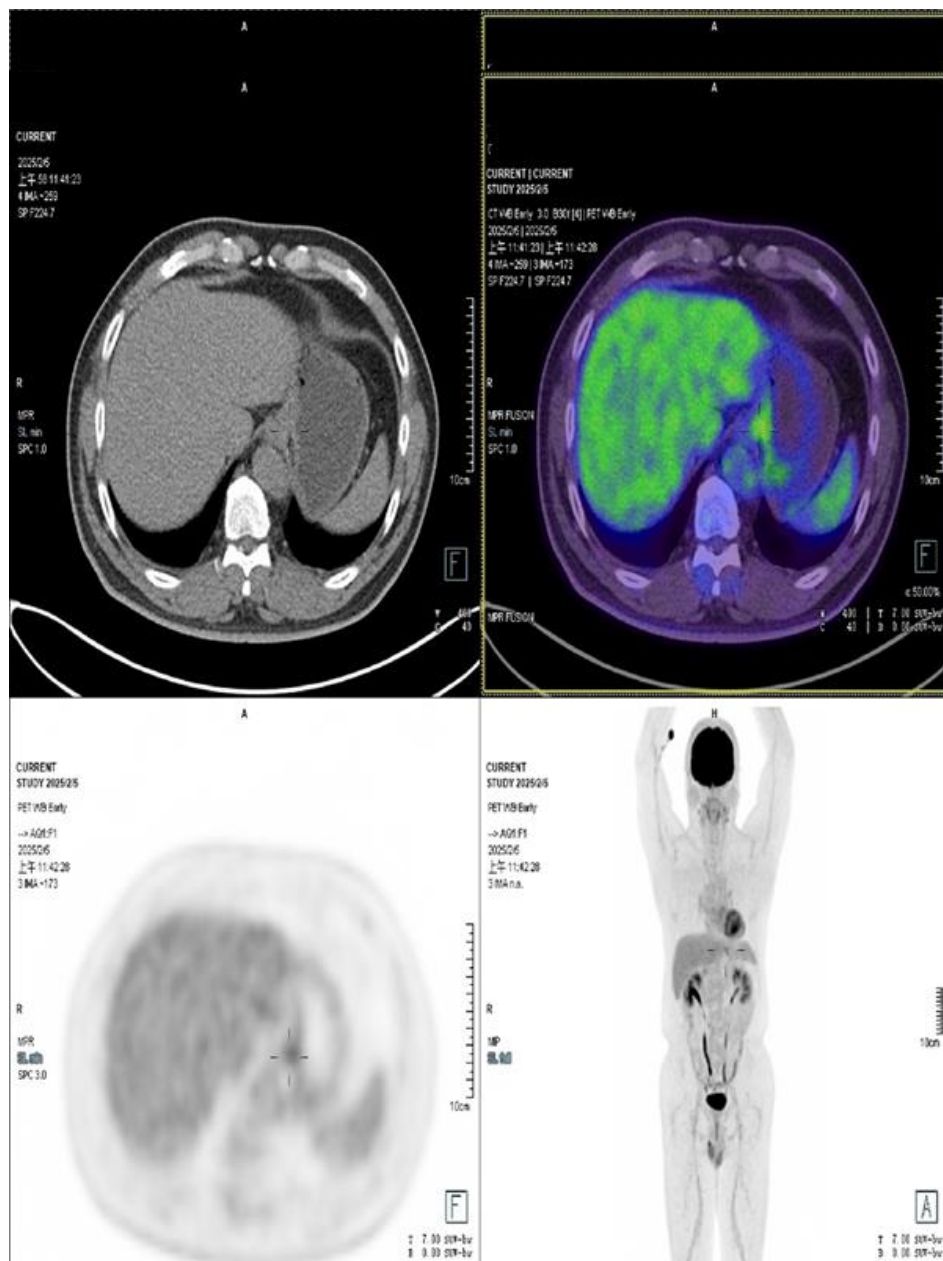
正子斷層造影



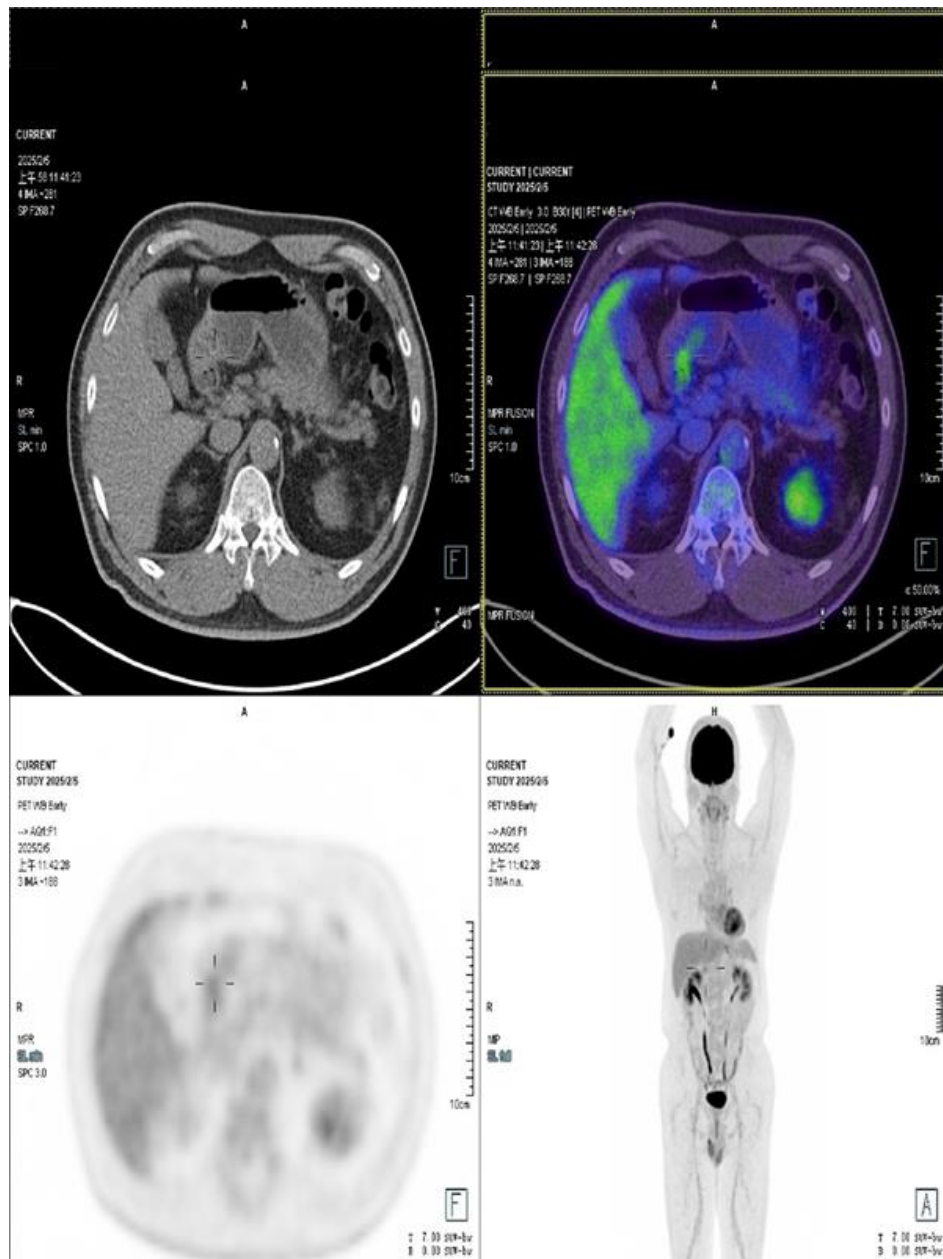
正子斷層造影



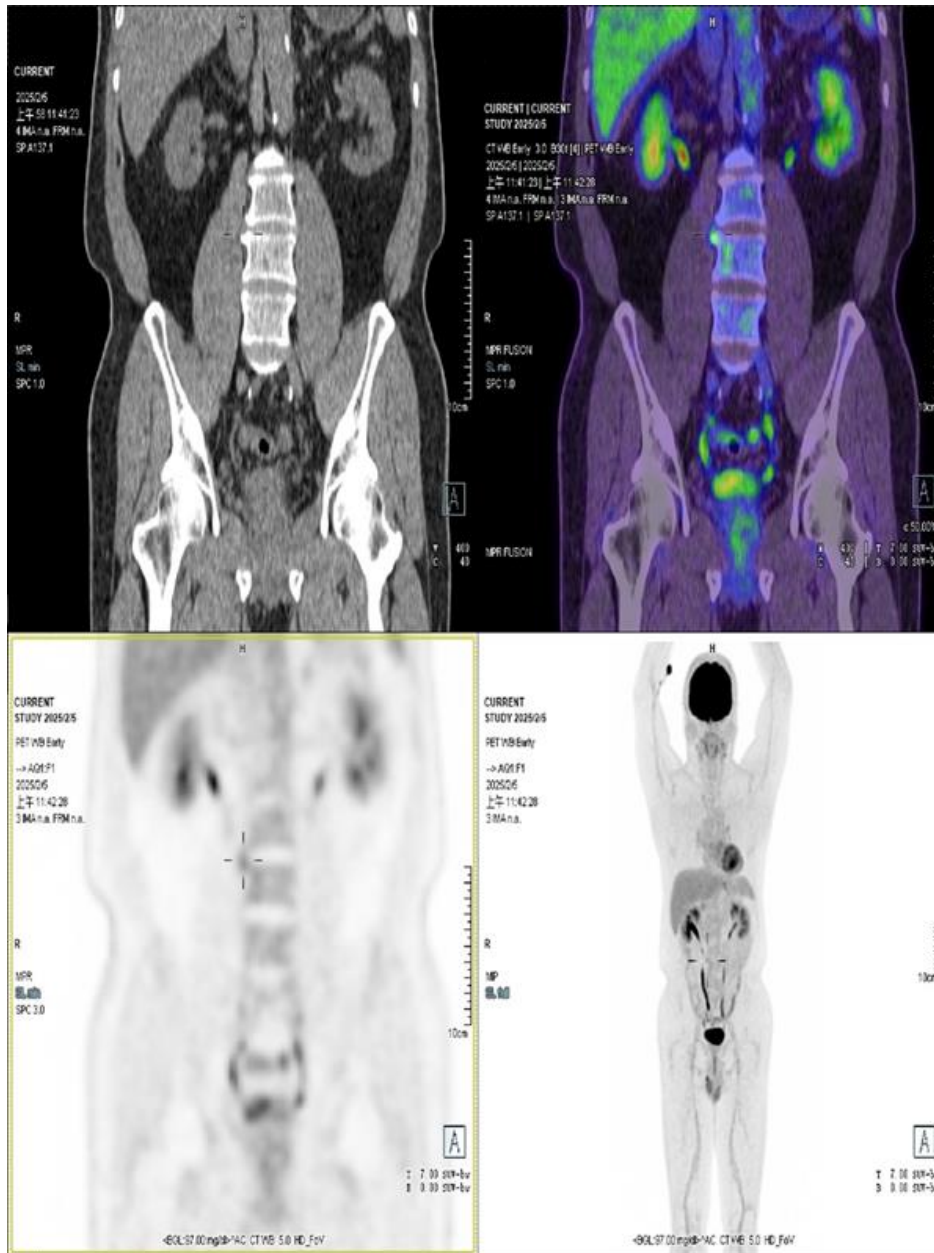
正子斷層造影



正子斷層造影



正子斷層造影



佛萊明罕 (Framingham Risk Score) 危險預估評估表

佛萊明罕 (Framingham Risk Score) 危險預估分數對照表

年齡	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74
女	-9	-4	0	3	6	7	8	8	8
男	-1	0	1	2	3	4	5	6	7

膽固醇(mg/dl)	<160	160-199	200-239	240-279	≥280
女	-2	0	1	1	3
男	-3	0	1	2	3

高密度膽固醇(mg/dl)	<35	35-44	45-49	50-59	≥60
女	5	2	1	0	-3
男	2	1	0	0	-2

血壓(mmHg)	<120/80	120-129/80-84	130-139/85-89	140-159/90-99	≥160/100
女	-3	0	0	2	3
男	0	0	1	2	3

糖尿病	無	有
女	0	4
男	0	2

吸菸	無	有
女	0	2
男	0	2

預估十年內發生冠心病的風險指數

您的分數	
年齡	4 分
膽固醇	-3 分
高密度膽固醇	0 分
血壓	1 分
糖尿病	2 分
吸菸	2 分
總分	6 分

冠心病發生的機率為 10 %

醫師總評:

您的心血管疾病十年風險屬於中度風險。